

Protocolos de Medicamentos Injetáveis IM / SC

Suplementação em drogaria – Modelo-base e fichas por ativo (São Paulo)

Versão 1.0 · Documento de trabalho para validação do farmacêutico responsável

Aviso importante. Este documento é um modelo estrutural e de apoio. Doses, intervalos e indicações mostrados são **faixas de referência gerais** e devem ser **conferidos na bula do produto específico** (registro ANVISA), em literatura atual e na prescrição. A validação clínica e jurídica final é do farmacêutico responsável. Itens marcados com [VALIDAR] não foram confirmados em fonte primária durante a elaboração.

1. Base regulatória (verificar versões vigentes)

- **RDC ANVISA 44/2009:** administração de injetáveis é serviço farmacêutico em farmácias/drogarias; exige farmacêutico (ou profissional habilitado com autorização do RT) presente ou supervisionando, serviço constando na licença sanitária, e apresentação de prescrição.
- **Res. CFF 585/2013 e 586/2013:** o farmacêutico prescreve livremente o que dispensa sem receita; medicamentos sob prescrição só com diagnóstico prévio e dentro de protocolo/diretriz/norma formalizada.
- **Estética injetável** (Res. CFF 616/2015 e 645/2017): em disputa judicial com o CFM e voltada a estabelecimentos de saúde estética. **Fora do escopo deste documento** até parecer do CRF-SP.
- Confirmar no CRF-SP: (a) serviço de injetáveis na licença da drogaria; (b) tabela de ativos que o CRF-SP aceita no protocolo de prescrição farmacêutica; (c) exigências de POP, treinamento e registro.

2. Fluxo geral do atendimento

Etapa	Conduta
1. Recepção	Conferir prescrição (nome, ativo, dose, via, intervalo, data, assinatura/carimbo) ou emitir prescrição farmacêutica conforme protocolo formalizado. Aplicar consentimento informado.
2. Triagem	Anamnese: alergias (inclusive cobalto/vitaminas), gestação/lactação, uso de anticoagulante/antiagregante, doenças renais/hepáticas/neurológicas, medicamentos em uso, exames prévios, aplicações anteriores e reações.
3. Verificação do produto	Rótulo, nome, concentração, lote, validade, integridade, aspecto (límpido, sem partículas, sem alteração de cor), proteção da luz quando exigida, cadeia de frio quando exigida.
4. Preparo	Higiene das mãos, luvas, material estéril descartável, antisepsia do local, checagem dos 9 certos.
5. Aplicação	Técnica por via (seção 3). Observar o paciente.
6. Pós-aplicação	Manter em observação por no mínimo 15–30 min [VALIDAR conforme POP local]. Orientar sobre efeitos esperados, sinais de alarme e retorno.
7. Registro	Data/hora, produto, lote, validade, dose, via, local, aplicador, intercorrências; cópia da prescrição retida conforme norma. Descarte em perfurocortante (RDC 222/2018).

3. Técnica por via

	Intramuscular (IM)	Subcutânea (SC)
Locais	Ventroglúteo (preferencial no adulto), vasto lateral da coxa; deltoide para pequenos volumes.	Abdome (evitar 5 cm ao redor do umbigo), face externa do braço e da coxa. Alternar locais.
Volume	Deltoide até ~2 mL; ventroglúteo/vasto lateral até ~3–5 mL por local.	Em geral até ~1–2 mL por local.
Agulha (referência)	25×7 a 30×8 (ajustar ao panículo adiposo e ao paciente).	13×4,5 a 13×4 ou conforme dispositivo.
Ângulo	90°, introdução firme; aspirar não é rotina em ventroglúteo [VALIDAR POP].	45° ou 90° conforme prega cutânea.

	Intramuscular (IM)	Subcutânea (SC)
Cuidados	Pressão local após; em anticoagulados, usar agulha fina e comprimir 2–5 min.	Não massagear após produtos de liberação prolongada; observar nódulos.

4. Emergência: anafilaxia (kit obrigatório no local)

- **Reconhecer:** urticária/prurido difuso, edema de lábios/língua, dispneia, sibilos, hipotensão, síncope, vômitos.
- **Adrenalina 1 mg/mL IM** na face anterolateral da coxa: adultos 0,3–0,5 mg; crianças 0,01 mg/kg (máx. 0,3 mg). Repetir a cada 5–15 min se necessário. **Acionar SAMU 192** imediatamente. [VALIDAR contra o protocolo adotado]
- Deitar o paciente com pernas elevadas (sentado se dispneia), oxigênio se disponível, monitorar sinais vitais até a equipe chegar.
- Registrar o evento e notificar (NOTIVISA/VigiMed). Treinamento anual de toda a equipe.

Kit mínimo: adrenalina, seringas/agulhas, anti-histamínico e corticoide conforme POP, luvas, gases, álcool 70%, recipiente perfurocortante, ficha de ocorrência, telefones de emergência.

5. Ficha 1 – Cianocobalamina (vitamina B12) IM/SC

Item	Conteúdo
Indicação	Deficiência documentada ou risco de deficiência: dieta vegetariana estrita/vegana, pós-cirurgia bariátrica, má absorção, anemia perniciosa, uso crônico de metformina/IBP/anti-H2, idosos com B12 baixa.
Evidência	Reposição parenteral é padrão em deficiência com má absorção. Sem deficiência, não há benefício demonstrado para energia, humor ou estética; evitar promessa terapêutica.
Crterios de inclusão	Prescrição válida e, de preferência, dosagem de B12 (e/ou homocisteína/MMA) recente.
Contraindicações	Hipersensibilidade à cianocobalamina/cobalto; neuropatia óptica de Leber. Atenção: suspeita de neoplasia.
Precauções	Início de tratamento de anemia megaloblástica: risco de hipocalemia – solicitar acompanhamento médico. Policitemia vera. Anticoagulação: preferir SC se bula do produto permitir.
Dose / esquema (referência)	Conforme a apresentação (ex.: 1.000 a 5.000 mcg por ampola). Esquema típico de ataque: 1.000 mcg IM/SC a cada 1–7 dias por algumas semanas, depois manutenção mensal. Seguir a bula do produto e a prescrição. [VALIDAR]
Via	IM profunda ou SC (conforme bula). Não administrar EV salvo bula expressa.
Interações	Cloranfenicol (resposta reduzida), metformina/IBP (reduzem absorção oral, razão da indicação parenteral), colchicina, neomicina.
Reações adversas	Dor/eritema local, prurido, cefaleia, tontura; raramente hipersensibilidade/anafilaxia, hipocalemia.
Monitorização	Resposta clínica e laboratorial (B12, hemograma) em 2–3 meses; encaminhar ao médico se não houver resposta.
Encaminhar ao médico	Anemia, sintomas neurológicos (parestesias, ataxia), idade avançada com déficit novo, gestação, ausência de causa clara da deficiência.

6. Ficha 2 – Complexo B injetável (B1 + B6 + B12 e/ou outras combinações) IM

Item	Conteúdo
Indicação	Neurite/neuropatia carencial, alcoolismo crônico, desnutrição, dor neuropática de componente carencial (adjuvante), conforme prescrição. Conferir a composição exata do produto.
Contraindicações	Hipersensibilidade a qualquer componente (especialmente tiamina). Doença de Parkinson em uso de levodopa isolada (B6 reduz efeito) [VALIDAR conforme combinação].
Precauções	Tiamina injetável: risco raro de anafilaxia – observar. B6 em doses elevadas/uso prolongado pode causar neuropatia sensitiva: não prolongar sem reavaliação. Gestantes e lactantes: só com orientação médica.
Dose / esquema (referência)	Em geral 1 ampola IM profunda a cada 1–3 dias por ciclos curtos (ex.: 3–10 aplicações) e reavaliação. Conforme bula do produto e prescrição. [VALIDAR]
Via	IM profunda (ventroglúteo/vasto lateral). Evitar SC salvo bula expressa. Não misturar com outros fármacos na seringa.
Interações	Levodopa (B6), fenitoína/fenobarbital (redução de níveis com B6 elevada), isoniazida e cicloserina (antagonismo da B6), álcool.
Reações adversas	Dor local, urticária, náuseas; raramente anafilaxia (tiamina). Coloração rósea da urina por riboflavina, se presente.
Monitorização	Sintomas neurológicos; suspender e encaminhar se piora, parestesia nova ou reação alérgica.

Item	Conteúdo
Encaminhar ao médico	Dor neuropática persistente, déficits motores, diabetes mal controlado, suspeita de causa estrutural.

7. Ficha 3 – Outros ativos a incluir após validação

Ativo	Situação / observação
Vitamina D (colecalfiferol) injetável	[VALIDAR] Existência de apresentação injetável registrada e disponível para uso em drogaria; geralmente a reposição é oral. Só incluir se houver produto registrado e prescrição.
Vitamina K (fitomenadiona)	Uso é terapêutico (coagulopatia/profilaxia), não suplementação; via preferencial e riscos (reações graves em EV) exigem prescrição médica e supervisão. Não recomendado para protocolo de drogaria.
Vitamina C, magnésio, zinco, glutatona, "blends" de soroterapia	Em geral EV, ou sem registro como injetável para este uso. Fora do escopo (sua habilitação é IM/SC) e de alto risco regulatório.

8. Termo de consentimento (modelo resumido)

Declaro que fui informado(a) sobre a finalidade, via, riscos (dor local, hematoma, reações alérgicas, incluindo reações graves) e alternativas do tratamento; que respondi com veracidade à triagem de saúde; que apresentei prescrição válida; e que autorizo a aplicação e o registro dos dados no prontuário do serviço, conforme a LGPD.

Paciente: _____ CPF: _____ Data: ____/____/____

Assinatura do paciente: _____ Farmacêutico (CRF-SP): _____

9. Ficha de registro de aplicação (modelo)

Data/hora	Paciente	Produto / lote / validade	Dose / via / local	Aplicador (CRF)	Intercorrência

10. Pendências antes do uso

- Conferir licença sanitária da drogaria (serviço de injetáveis) e POPs.
- Escolher os produtos comerciais e transcrever dose/intervalo da **bula** de cada um nas fichas.
- Definir se a prescrição será médica ou farmacêutica sob protocolo formalizado (Res. CFF 586/2013, art. 6).
- Validar com CRF-SP os itens [VALIDAR]; revisar o documento a cada 12 meses ou mudança normativa.
- Estética injetável: aguardar parecer do CRF-SP; não aplicar o modelo ao estético.